

Fecha Última Actualización: 21-01-2026 22:16:28

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Maria Eugenia Abarca Valenzuela
Edad : 69a 3m 28d
Dirección : Capitan Avalos 0122

Rut : 8.543.520-5
Fecha Nacto: 24/09/1956
Comuna : La Granja

N° Archivo : A178779
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 9999 9999

N° Epicrisis
469398

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 05/01/2026 14:36

Días Estadía: 16

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 21/01/2026 22:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Traslado desde HPH x Compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

RESUMEN DE TRASLADO UCI

FI CASR: 05.01.2026
FI UCI: 05.01.2026
FE HSR: 21.01.2025

Diagnósticos:

- 1.AC.V isquémico cerebeloso derecho
 - a.Oclusión PICA derecha
 - b.NIHSS 7 ptos (Alerta 2, preguntas 2, ordenes 1, Disartria 2)
 - c.Hidrocefalia Aguda secundaria
 - i.Craniectomía descompresiva occipital + DVE (05.01)
- 2.NAC Aspirativa en manejo
- 3.Antecedentes HTA, DM2, Retinopatía Diabética con amaurosis parcial ODI

Anamnesis:

Pcte con antecedentes descrtios. Datos obtenidos de ficha médica, sin familiares al momento del ingreso.

Consulta inicialmente en HPH el 03 de enero, inicia con mareos y lateropulsión de marcha derecha, asociado a náuseas y vómitos a repetición. Instalación brusca de síntomas. Paciente vigil. Falla en edad por 2, identifica mes actual. Cierra los ojos y toma la mano a la solicitud. Mirada conjugada, sin lateralidad preferente. Pupilas isocóricas, sin evidente ptosis palpebral (muy discreta menor apertura a izquierda), Horner negativo. Discreto nistagmus vertical en mirada hacia arriba. Campo visual conservado en 4 cuadrantes por confrontación. Activación facial simétrica. Activación velopalatina simétrica. Corneales sin categórica asimetría. Lengua protruye central. Sin claudicación de EESS en 10". Sin claudicación de EEII en 5". Metría impresiona con algo de torpeza en 4 extremidades, pero a efectos de puntuación, considero conservada en ambas EESS (índice-nariz-índice) y en ambas EEII (talón-rodilla-tobillo). Sensibilidad percibida simétrica. Nomina, repite, comprende. Sin disartria. Explora ambos hemisferios, sin extinción visual o táctil. NIHSS: 1 (preguntas 1 - posiblemente sin relación a ACV). TAC de Cerebro + Angiotac de Cerebro y Cuello (realizado > 12 hrs desde inicio de síntomas): "Impresión: Ausencia de claro realce en porción distal de la arteria cerebelar postero inferior derecha. Lesión isquémica aguda cerebelar inferior mesial derecha. Resto de los grandes vasos del cuello y encéfalo con cambios ateromatosos, sin estenosis significativa."

Se decide hospitalización para estabilización en HPH. Evolución con compromiso cualicuantitativo de conciencia y agitación

Fecha Epicrisis : 21/01/2026 22:16

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 21-01-2026 22:16:28

Página 2 de 3

psicomotriz agregándose plantar extensor izquierdo que previamente no se encontraba objetivado. Se solicita nuevo TC de Cerebro que impresiona presencia de hidrocefalia aguda.

Se solicita traslado a CASR para evaluación por NCx. Ingres a en glasgow 9 (o2-v2-m5), no obedece ordenes simples, pupilas isocoricas reactivas, plantar extensor bilateral. Se decide IOT y se presenta a NCx, quienes decide manejo quirúrgico.

Protocolo Quirurgico describe:

1.- INSTALACIÓN DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO EN POSICIÓN SUPINO.

2.- EN SEGUNDO TIEMPO SE REALIZA CRANECTOMÍA DESCOMPRESIVA DE FOSA POSTERIOR BIPARIETAL.

Posteriormente se traslada a UCI.

Evolución en UCI:

Ingres a sedada, conectada a VMI, con DVE in situ. Evolucion a de manera favorable en lo hemodinámico, se suspende DVA al 3er día. Evaluada por NC. se decide iniciar despertar, pero con tendencia a la HTA, por lo que requiere ajuste de los vasodilatadores.

Se logra avanzar en weaning, con buena mecánica ventilatoria, buen intercambio de O2

Sin falla renal, diuresis adecuada

En lo neurológico moviliza las extremidades inferiores y la superior derecha, rechaza al dolor, obedece 1/5 órdenes, con apertura ocular espontanea

Hace 2 días con parámetros inflamatorios al alza , en este conetxtto se pancultiva e inicia AB empirico con Meropenem + Vancomicina, a la espera de resultado de cultivos para optimizar terapia. Citoquimico de LCR NO INFLAMATORIO

En lo respiratorio, en modo CPAP, intentando avanzar en weaning

Se extuba sin incidentes el 17/01 a las 15.50 hrs con apoyo de VMNI, que rápidamente se retira y deja con NRC. Con weaning consolidado. Actualmente con NRC 3 lts, saturando 98%

En lo neurológico, evoluciona de forma favorable, con cierre de DVE ayer 17/01 , en plan de TAC cerebral hoy o SOS si deterioro neurologico.

Con función renal normal, diuresis adecuada. No es problema actu al

En lo infeccioso, con ele vación de PPII desde el 11/01 , se solicita estudio microbiologico el 14/01 y se escaló a meropenem , actualmente afebril, sin clinica infecciosa con caída de PPII, y estudio infeccioso negativo (PL , UC y HC 1-2).

Plan de completar 5-7 días de ATB empiricos y vigilancia de PPII. Se suspendió Vancomicina, debido a que cultivos persisten negativos. Por ahora se mantiene con Meropenem

Ayer se retira DVE y es dada de alta x N.C. TAC de cerebro control de hoy, sin mayor complicación

Debe trasladarse a unidad de menor complejidad

Examen Físico:

Con apósito de craneotomia descompresiva occipital con líquido seroso

Corazón: RR en 2t s/s

Pulmones: MP disminuido levemente en la bases

Abdomen: globuloso, blando, RHA +

Extremidades: tibias a distal

Neurológico: moviliza las 4 extremidades, obedece órdenes simples

Planes:

De alta x N.C.

Completar tto antibiótico

KTR y motora full

Continuar neurorehabilitación

Traslado a UTAC o HPH

Diagnóstico de Egreso

Accidente vascular isquémico - Oclusion de la PICA derecha / Hidrocefalia / DVE / Craneotomia descompresiva occipital

Condición de Egreso Alta Derivado al Hospital Padre Hurtado

Egreso con Catéter Doble J:NO

En resumen de traslado

Plan Post Alta

En resumen de traslado

Fecha Epicrisis : 21/01/2026 22:16

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 21-01-2026 22:16:28

Página 3 de 3

Pendiente realizar IC para controles al alta

Indicaciones

Tipo de Reposo : Fresubin Hp A 60 MI/Hr Por Sng

Régimen Alimentario : Nutrición Enteral

Medicamentos : Quetiapina 25 Mg Ne La Noche Por Sng
Meropenem 1gr 1 Gr Cada 8 Hrs (Empírico, Hasta 21/1)
Levetiracetam 500 Mg 1 Cada 12 Hrs Por Sng
Enoxaparina 40 Mg 0,4 MI 40 Mg Al Día Sc

Controles

INTERNO

Becado/Residente



John Gutierrez González

Médico Tratante (Staff)